



DBT

MATERIAL DE APOIO · AULA 06 DE 12

Análise em cadeia, de soluções e de missing link

A análise em cadeia pega cada elo entre o gatilho e o comportamento-alvo, entende a função dele e só depois escolhe onde mexer. Solução proposta antes disso vira orientação vazia.

ENCONTRO DE SÁBADO, 19 DE SETEMBRO DE 2026 · 10H ÀS 12H
CONDUZIDO POR JÚLIO GONÇALVES

DESCOMPLICANDO A DBT

Quem conduz a formação

Doze encontros ao vivo, aos sábados, para sair da leitura sobre DBT e chegar na condução da sessão — da teoria biossocial ao manejo de crise, com o pé na prática clínica.



IDEALIZADOR · PROFESSOR

Júlio Gonçalves



IDEALIZADORA · PROFESSORA

Andressa Juliana

Este material acompanha o encontro

As últimas páginas são preenchíveis: marque o checklist, responda as perguntas de revisão e guarde suas anotações no próprio arquivo. Salve depois de preencher.

O ESSENCIAL

- **A análise em cadeia é mais detalhada que a análise funcional clássica.** Mudar contingência leva tempo, e numa desregulação frequente esse tempo não existe. Por isso se intervém direto nos elos.
- **O centro é sempre a função do comportamento-alvo.** Na maior parte das vezes ela é regular a dor emocional.
- **Monte a cadeia inteira antes de propor qualquer mudança.** Sugerir solução no meio da análise invalida o único repertório que a pessoa tem.
- **Quando a habilidade combinada não aparece, investigue o elo que faltou.** Perguntar "por que tu não fez?" só aumenta a vergonha.

01 Por que a DBT detalha tanto

Quem vem da análise do comportamento vai reconhecer os conceitos. A diferença é o grau de detalhe. A análise funcional mais geral costuma apostar no manejo de contingências, mudando o ambiente. Com um paciente que se desregula com frequência, isso não basta, porque mudar ambiente demora e a crise não espera.

Linehan separou em elos o que na análise clássica fica tudo junto na "resposta": pensamento, emoção, sensação e ação, cada um no seu lugar. Com isso fica claro onde olhar e onde intervir.

02 A ordem dos alvos continua valendo

As sessões começam pela hierarquia. Se há comportamento que ameaça a vida, a análise em cadeia vai sobre ele, e isso pode levar semanas ou meses, até abrir janela de tolerância para o resto.

As fronteiras não são rígidas. Comportamentos que interferem na terapia costumam aparecer junto, porque mexer no que dói afasta o paciente. A regra é esta: só se desce para o nível dois ou três quando ele está atrapalhando o trabalho no nível um. Na prática, os comportamentos de qualidade de vida entram quase sempre como vulnerabilidade dentro da cadeia.

03 As peças da cadeia

O caso usado em aula foi o da Bruna, construído para fins didáticos. Ela dormiu quatro horas, não almoçou e se atrasou no estágio. Às 16h mandou mensagem para o namorado, que visualizou e não respondeu.



A cadeia da Bruna nas cinco posições. O que é consequência hoje volta como vulnerabilidade amanhã.

- **Vulnerabilidade** tem duas camadas. A longitudinal é a história de vida, práticas parentais, modelos. A transversal é o que aconteceu nos últimos dias e mexeu na biofisiologia: sono, comida, dor, álcool, briga que ficou ruminando, tarefa que ativou o "eu sou incompetente".
- **Precipitante** é o gatilho. Tem hora e costuma ser algo do ambiente: uma mensagem, uma fala, um olhar, um atraso. Pode ser também interno, como uma memória ou um pensamento.
- **Elos** são tudo o que vai somando entre o gatilho e o alvo. Eventos privados, como pensamento, ruminação, desejo e impulso, e eventos abertos, que são as ações. Andar pela casa é ação, não é o comportamento-alvo.
- **Comportamento-alvo** é descrito com precisão: o que, onde, quando e com que intensidade. Isso já corrige o "surtei o dia inteiro" e mostra ao paciente que a emoção muda em minutos.

- Consequências imediatas acontecem segundos depois e têm o maior controle sobre o comportamento. Olhe três lugares: o corpo, o ambiente e as outras pessoas.

04 Precipitante é a gota d'água

Surgiu a dúvida sobre um estressor que se arrasta por dias. O critério dado em aula foi direto: o precipitante é o evento sem o qual o comportamento-alvo não teria acontecido naquele dia. O resto entra como vulnerabilidade.

A cadeia também não é uma reta. Uma consequência pode virar precipitante de outra cadeia, e o desenho vai ficando parecido com uma árvore de decisão. O que organiza é o comportamento-alvo escolhido para aquela sessão. Um comportamento que numa análise foi o alvo pode, em outra, ser só um elo.

O alvo muda conforme a semana

Se na semana seguinte a Bruna não se lesionou, mas passou dias checando o celular do namorado, esse passa a ser o alvo. A autolesão da semana anterior, que ela ficou ruminando, entra como vulnerabilidade. Se ela chega dizendo que quer desistir da terapia, o alvo passa a ser esse, porque interfere no tratamento.

05 A função, e a conversa sobre "chamar atenção"

Pela teoria biossocial, a maior parte dos comportamentos-alvo serve para regular emoção. Olhe qual emoção está no centro dos elos. Ela costuma se repetir e vem da história: vergonha, raiva, tristeza, e no funcionamento borderline, muito frequentemente, rejeição e abandono.

No caso da Bruna, a função principal é o alívio da dor emocional. O namorado ligando também mantém o comportamento, mas o alívio é o que mexe na biofisiologia dela.

O AJUSTE QUE A TURMA PROVOCOU

A aula afirmou que o comportamento nunca é "para chamar atenção". A turma questionou com o exemplo da birra infantil, e a posição foi ajustada em sala. A atenção pode reforçar o comportamento depois, sem que a pessoa tenha tido essa intenção. Na desregulação o comportamento é automático e ninguém calcula "vou fazer isso para ver o que acontece". A falta de outro repertório faz a mesma resposta ser usada em vários contextos. O rótulo "chamar atenção" continua fora da análise, porque é julgamento, e o que se investiga é o que o comportamento regula.

Ao longo da análise, fica uma pergunta de fundo: faltou motivação ou faltou habilidade? As condutas são diferentes para cada caso.

06 Descrever como cena de filme

"Bebi muito" não cabe numa cena. Uma câmera grava outra coisa: às 16h, sentada no bar, pediu a primeira cerveja olhando o celular. Em duas horas foram dez, enquanto checava se o namorado estava online.

Descrever assim, sem resumo e sem rótulo, ancora o paciente no tempo. A desregulação aconteceu naquele período, não o dia inteiro. Também permite medir frequência e força, que é o que o cartão diário ajuda a acompanhar. Às vezes a segunda-feira parece controlada e já deixa vulnerabilidade para a terça, que deixa para a quarta, até estourar na sexta. Aí a intervenção começa na segunda.

Perguntas que ajudam: se eu tivesse uma câmera, o que ela gravaria? Que horas eram? E, para as consequências: um, dois segundos depois, o que tu sentiu?

07 Como conduzir na sessão

Antes de começar, diga o que vai fazer e peça a concordância: quero entender exatamente o que aconteceu, tu topa fazer isso comigo? Use o nome "análise em cadeia". Isso cria linguagem compartilhada, deixa claro que existe um objetivo e ajuda a reatribuir a culpa, porque boa parte da cadeia independe da vontade da pessoa.

Comece sempre pelo comportamento-alvo e pelo precipitante. Depois, siga o ritmo do paciente. Se ele está narrando os elos, vá por eles e deixe as vulnerabilidades para depois. Se ele começa pela semana ruim, vá pelas vulnerabilidades. O objetivo é não cortar o fluxo nem jogar água fria num relato que está vívido.

- **Isole um evento.** Quando vem muita coisa junta, pegue o comportamento mais ameaçador e foque nele.
- **Encurte o tempo até o gatilho.** O término de um mês atrás não explica a autolesão de hoje. Vá fazendo perguntas até chegar no que aconteceu algumas horas antes.
- **Fique no presente.** Analisar episódios muito antigos gasta sessão sem proteger contra o próximo. A história entra só para psicoeducar que a biofisiologia pesa.
- **Não mexa na consequência no começo.** Com o paciente desregulado, o manejo de contingência fica para depois, com família e nas relações.

08 Postura e armadilhas

Cabeça de investigador, sem julgamento e com calma. A tendência de todo terapeuta é acelerar, e a análise em cadeia pune essa pressa.

A VALIDAÇÃO QUE AQUECE O COMPORTAMENTO

"Nossa, deve ter sido muito difícil" parece validação. No meio da análise em cadeia, pode aquecer justamente o comportamento que se quer reduzir. Se a relação já tem base de aceitação, dá para ir direto: tu mandou a mensagem, ele não respondeu, tu ficou sozinha em casa e se cortou. Entre ficar sozinha e se cortar, o que aconteceu?

As armadilhas nomeadas em aula foram quatro: ficar tempo demais num único ponto, focar só na vulnerabilidade, voltar para o passado e intervir antes de a cadeia estar montada. Questionar um pensamento no meio da análise ("que evidência tu tem?") pode até ser útil, mas depois, com a cadeia inteira à vista.

A vergonha e a vontade de esconder vão aparecer. O paciente começa a falar do namorado, do término, da ex, e sai do corte. A saída é nomear e voltar: a gente tem pouco tempo e eu quero olhar para isso com calma. Se a evitação continuar, ela vira o alvo. A gente não vai falar da autolesão agora, vai falar do não querer falar. Isso costuma ser mais fácil, e o fato de o paciente ter ido à sessão mesmo assim mostra que a motivação está ali.

Visual ajuda. Pôr a cadeia na tela, mandar uma cópia no final, ou um material interativo que o paciente abra no celular para rever o padrão.

09 Do mapa à solução

Uma cadeia só não basta. A ideia é fazer várias até achar o padrão: as mesmas consequências mantendo, as mesmas vulnerabilidades. Aí se decide por onde começar.

**Escolher
o elo junto**

**Gerar várias
soluções**

**Escolher a
mais acessível**

**Ensalar
na sessão**

**Prever o que
pode dar errado**

**Compromisso
curto e datado**

Se muita coisa pode dar errado, volte às soluções. Fácil aqui quer dizer possível hoje, e ainda assim é mudança a reforçar.

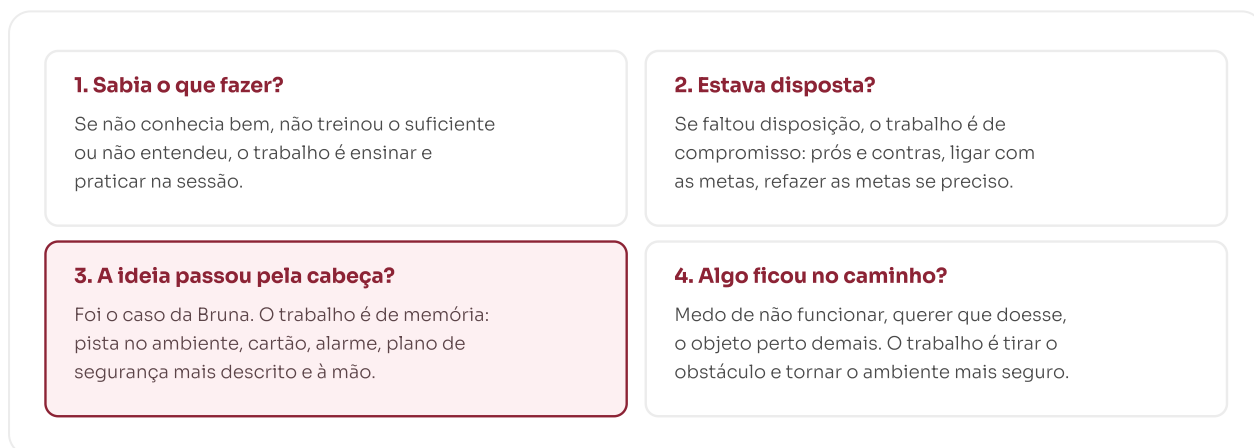
A sequência depois da cadeia montada. As habilidades são ensaiadas fora da crise para estarem na memória quando a crise vier.

No caso da Bruna, o elo escolhido foi ler o silêncio como rejeição e se isolar. Com a cadeia já entendida, cabe uma reestruturação mínima: da última vez era trabalho, será que na próxima dá para trazer isso como pensamento alternativo? Entram também ação oposta (querer ficar no quarto e ir para a sala com alguém), ligar para a irmã que sempre atende, mandar uma mensagem só e segurar o impulso da segunda, autoacalmar e, em último caso, o coaching por telefone.

Todas as soluções caem em uma das categorias já vistas: habilidades, exposição, manejo de contingências ou modificação cognitiva. A análise não termina aí. As próprias intervenções viram objeto de novas análises, inclusive para mostrar ao paciente que funcionou.

10 O elo que faltou

A Bruna já conhecia a habilidade combinada e estava disposta a usar. Quando entrou no banheiro, não lembrou dela. Esse é o missing link: o paciente tem o repertório, e alguma coisa impediu que ele aparecesse.



As quatro perguntas, na ordem. Cada resposta leva a uma conduta diferente.

A pergunta "por que tu não fez?" invalida e gera reatância. A resposta vira "não sei", a vergonha sobe e isso é mais vulnerabilidade. Troque por: tudo bem, não deu, vamos ver junto onde travou. Entre o momento em que tu entrou no banheiro e o momento em que podia ter usado a habilidade, o que aconteceu?

No caso da Bruna, a resposta foi memória. Por isso a conduta foi deixar o recurso mais visível e mais à mão, e não repetir que ela precisava querer mais.

Uma ideia sem evidência publicada

Foi comentada a caixa de regulação: uma caixa grande, num lugar da casa onde o paciente não tenha como não ver, com itens sensoriais de que ele goste e frases que ele mesmo disse na terapia. A função é visual e de memória. Não há estudo publicado sobre isso, e a aula disse exatamente isso.

11 O que a prática em grupo mostrou

A turma trabalhou o caso da Bruna em três salas, Mente Sábia, Ação Oposta e Aceitação Radical, com camadas liberadas por senha. O tempo ficou curto, e o exercício segue em casa. O retorno dos grupos deixou quatro lições.

- **Com pouca informação, comece mesmo assim.** A primeira camada era propositalmente curta, como o relato real de um paciente. Ela já basta para formular a primeira pergunta da cadeia.
- **Pergunta geral atrasa.** "Vamos tentar entender o que te levou a isso" chega ao mesmo lugar, só que mais devagar e perdendo o aquecimento do relato. Melhor descrever o que ela trouxe e perguntar pelo intervalo.
- **A metáfora do filme funciona.** Pedir que a pessoa conte as cenas do que aconteceu foi a proposta mais elogiada.
- **Aceitação é linha de base, não etapa.** Um grupo se preocupou em chegar à aceitação e acabou perguntando o que ela poderia fazer diferente antes de a cadeia estar pronta. Com boa intenção, isso vira mais uma pessoa dizendo o que ela deve fazer. A aceitação acompanha o processo inteiro.

12 Levar para a prática

PRÓXIMO ENCONTRO

Os primeiros minutos da aula de compromisso e manejo de crises vão ficar para dúvidas e impressões sobre o exercício. O gabarito do caderno sai junto.

14 Referências

- Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press. Análise comportamental e análise de soluções.
- Rizvi, S. L. (2019). *Chain analysis in dialectical behavior therapy*. Guilford Press. Série Guilford DBT Practice.

NOTA DE MÉTODO

Resumo escrito a partir da transcrição do encontro. Participantes não são identificados. A Bruna é um caso construído para fins didáticos. A afirmação de que o comportamento nunca serve para chamar atenção foi ajustada em sala, e o texto traz a posição final. Na descrição do caso omiti o instrumento usado na autolesão e deixei de fora a lista de alternativas que produzem dor sem lesão citadas em aula, por não serem necessárias ao raciocínio da cadeia. O livro de Rizvi foi conferido na editora. Os diagramas foram desenhados a partir do conteúdo da aula.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão. O arquivo guarda o que você preencher.

- ☐ Terminei o caderno do caso da Bruna, sozinha ou com o grupo, até a camada do missing link.
- ☐ Fiz uma análise em cadeia de um paciente meu, começando pelo alvo e pelo precipitante.
- ☐ Descrevi o comportamento-alvo como cena de filme, com hora, lugar e intensidade.
- ☐ Segurei qualquer sugestão de solução até a cadeia estar inteira.
- ☐ Numa tarefa não feita, troquei o "por que tu não fez?" pelas quatro perguntas do missing link.

Minhas anotações — o que levo para a clínica

Para revisar — resposta

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

01. Um paciente passou uma semana difícil depois de um término e ontem se lesionou. Como tu decide o que é vulnerabilidade e o que é precipitante?

02. Por que "deve ter sido muito difícil pra ti" pode atrapalhar no meio da análise em cadeia?

03. O paciente começa a falar da ex do namorado e sai do assunto da autolesão. O que tu faz?

04. A paciente sabia a habilidade, estava disposta e mesmo assim não usou. Qual pergunta do missing link isso aponta e qual é a conduta?